

Université de Monastir

Faculté de Médecine de Monastir



Année universitaire 2024 / 2025

Préparation à l'Examen Classant National

Questions d'évaluation

Sujet n° 35

HEPATITES VIRALES

Pr. Ag. Mohamed Hichem LOGHMARI

Service d'Hépatogastroentérologie

CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

Séance du 04 Juillet 2025

Q35- Hépatites virales

I- Epreuve QCM (37 questions)

1. Le virus de l'hépatite A est transmis :

- A. Par voie parentérale
- B. Par voie féco-orale
- C. Par relations sexuelles oro-anales
- D. Par lait maternel
- E. Par consommation d'aliments contaminés

2. Les facteurs de risque d'infection par le virus de l'hépatite A sont :

- A. Voyage en zone d'endémie
- B. Alcoolisme chronique
- C. Non-vaccination dans un pays d'endémie
- D. Travail dans une station d'épuration des eaux
- E. Contact avec des animaux sauvages

3. Le virus de l'hépatite E peu être transmis :

- A. Par consommation d'aliments contaminés
- B. Par contact avec les animaux tels que le porc
- C. Par voie materno-fœtale
- D. Par les rapports sexuels non protégés
- E. Par transfusion sanguin.

4. Les principaux modes de contamination par le virus de l'hépatite B sont:

- A. Par voie sexuelle
- B. Par transmission horizontale intrafamiliale
- C. Par allaitement (haut risque)
- D. Par transmission sanguine
- E. Par transmission verticale mère-enfant, surtout lors de l'accouchement.

5. Les groupes à risque d'infection par le VHB sont :

- A. Patients hémodialysés
- B. Usagers de drogues intraveineuses
- C. Détenus
- D. Personnel de santé
- E. Travailleurs dans les stations d'assainissement

6. Concernant l'infection par le virus de l'hépatite D :

- A. Elle peut toucher des sujets non porteurs du VHB
- B. Elle nécessite la présence de l'AgHBs pour produire des particules virales
- C. La contamination se fait par voie sanguine
- D. Sa co-infection avec le VHB augmente le risque de forme fulminante
- E. Elle est fréquente en Tunisie

7. Le virus de l'hépatite C (VHC) se transmet :

- A. Par voie parentérale
- B. Par relations sexuelles fréquentes
- C. Par inhalation de gouttelettes
- D. Par transfusion de produits sanguins contaminés
- E. Par voie oro-fécale

8. Parmi les caractéristiques du virus de l'hépatite B vous retenez :

- A. Un virus enveloppé
- B. Il possède une activité reverse transcriptase
- C. Il possède un seul génotype
- D. Un virus à ADN circulaire
- E. Un virus oncogène

9. Concernant les marqueurs sérologiques de l'hépatite B:

- A. L'AgHBs est un marqueur d'infection
- B. L'Anti-HBc IgM est un marqueur d'infection aiguë ou récente
- C. L'AgHBe est un marqueur de virus mutant
- D. L'Anti-HBs est un marqueur d'immunisation
- E. L'Anti-HBe est un marqueur de disparition de la réplication virale (sauf mutant)

10. Le profil sérologique B suivant : AgHBs négatif, anti-HBs positif, anti-HBc IgG positif, est en faveur de :

- A. Sujet vacciné
- B. Sujet immunisé après une infection passée
- C. Sujet naïf de toute infection virale B
- D. Infection chronique B
- E. Infection aigue B

11. Vous indiquez un traitement antiviral B dans les situations cliniques suivantes :

- A. Cirrhose avec ADN viral B détectable
- B. AgHBe positif
- C. ADN viral B > 20 000 UI/mL qq soit le reste des paramètres
- D. Ac anti-HBc type IgM positif
- E. ADN viral B > 2000 UI/mL associé à des lésions hépatiques Métavir $\geq$ F2

12. Les principaux objectifs thérapeutiques dans l'hépatite B chronique sont :

- A. Normalisation des ALAT
- B. Perte de l'AgHBs
- C. Virosuppression (ADN viral B indétectable)
- D. Séroconversion AgHBe $\rightarrow$ anti-HBe
- E. Elimination complète du virus B

13. Les médicaments utilisés actuellement pour le traitement du virus B sont :

- A. Lamivudine
- B. Entecavir
- C. Ténofovir
- D. Sofosbuvir
- E. Ribavirine

14. La surveillance des patients sous traitement antiviral B se base sur :

- A. Bilan hépatique régulier
- B. Dosage de l'ADN viral B
- C. Suivi de la densité osseuse
- D. Évaluation de la fibrose
- E. Surveillance du carcinome hépatocellulaire

15. L'hépatite E est caractérisé par les éléments suivants :

- A. Elle peut évoluer vers une forme chronique chez l'immunodéprimé
- B. Il existe un vaccin en Chine
- C. La forme aiguë est souvent asymptomatique
- D. L'infection est grave chez la femme enceinte
- E. Le diagnostic repose sur la biopsie hépatique

16. Les patients à risque de forme grave d'hépatite E sont :

- A. Femmes enceintes
- B. Patients immunodéprimés
- C. Patients ayant une stéatose hépatique
- D. Patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
- E. Diabétiques sous insuline

17. Le traitement antiviral C est actuellement indiqué dans les situations suivantes :

- A. Si ARN viral C > 2000 UI/mL
- B. Uniquement en cas de fibrose > F2
- C. Uniquement chez les immunodéprimés
- D. Toute personne avec ARN viral C détectable
- E. En cas de co-infection VHC-VIH

18. Une hépatite aiguë D de type coinfection est retenue devant le profil virologique suivant :

- A. Ag HBs (+) et Ac anti HBc IgG (+), Anti VHD (+), ARN du VHD (+)
- B. Ag HBs (+) et Ac anti HBc IgM (+), Anti VHD (+), ARN du VHD (+)
- C. Ag HBs (+) et Ac anti HBc IgM (+), Anti VHD (+), ARN du VHD (-)
- D. Ag HBs (-) et Ac anti HBc IgG (+), Anti VHD (+), ARN du VHD (-)
- E. Ag HBs (+), Ac anti HBc IgM (-), Ac anti HBc IgG (-), Anti VHD (+), ARN du VHD (+)

19. Le vaccin contre l'hépatite B :

- A. Contient l'AgHBs recombinant
- B. Est administré par voie IV
- C. Est systématique chez les professionnels de santé
- D. Est contre-indiqué chez la femme enceinte
- E. Est jugé efficace si le taux de l'anti-HBs > 10 UI/mL

20. Le traitement antiviral B recommandé pour la prophylaxie de la transmission verticale du virus B est

- A. Lamivudine
- B. Entécavir
- C. Interféron pégylé
- D. Ténofovir
- E. Sofosbuvir

21. Les moyens qui permettent de prévenir la transmission du virus B sont:

- A. Vaccination
- B. Port de gants lors de soins
- C. Stérilisation du matériel médical
- D. Traitement systématique des sujets contacts
- E. Utilisation de préservatifs

22. Les manifestations extra-hépatiques possibles de l'infection par le VHB sont:

- A. Polyarthrite
- B. Glomérulonéphrite membrano-proliférative
- C. Vascularite cryoglobulinémique
- D. Syndrome de Guillain Barré
- E. Fibrose pulmonaire diffuse

23. Le traitement de l'hépatite chronique E se base sur:

- A. Lamivudine
- B. Entécavir
- C. Ribavirine
- D. Sofosbuvir
- E. Lédipasvir

24. En cas d'accident d'exposition au sang chez un sujet non vacciné contre le virus B, votre conduite sera :

- A. Administrer une dose de vaccin anti-VHB
- B. Administrer des immunoglobulines spécifiques
- C. Contrôler les sérologies virales du contact source
- D. Administrer d'emblée un traitement antiviral de type Interféron alpha
- E. Administrer d'emblée un traitement antiviral de type Entécavir

25. Les marqueurs de réplication virale B sont:

- A. ADN VHB détectable
- B. AgHBe positif
- C. Anti-HBs
- D. IgM Anti-HBc
- E. Ag HBs

26. Les mesures préventives recommandées contre le virus de l'hépatite E sont :

- A. Cuisson suffisante de la viande
- B. Vaccination systématique
- C. Port de gants et de bottes chez les vétérinaires
- D. Lavage des mains
- E. Pasteurisation du lait

27. Les gestes de soins qui peuvent transmettre une hépatite virale B sont :

- A. Injection avec seringue usagée
- B. Mauvaise désinfection du matériel
- C. Application d'un sparadrap sur la peau d'un sujet infecté
- D. Aérosols respiratoires
- E. Transfusion sanguine

28. Chez un patient ictérique, le diagnostic d'une hépatite aiguë virale A est évoqué devant:

- A- La notion de transfusion sanguine dans les 2 mois qui ont précédé l'ictère
- B- La notion d'hépatite virale aiguë dans l'entourage
- C- Le travail du patient dans une station d'assainissement.
- D- Des scarifications récentes
- E- Un taux élevé de bilirubine directe.

29. Au cours d'une hépatite aiguë, les éléments qui font craindre une forme fulminante sont :

- A- Un ictère foncé
- B- La présence de fièvre.
- C- La survenue d'accès confusionnels
- D- Un astérixis
- E- Une élévation importante des transaminases.

30. Les marqueurs sérologiques retrouvés positifs dans une hépatite B ancienne « guérie » sont :

- A- Antigène HBs
- B- Ac anti HBc de type IgM
- C- Ac anti-HBc de type IgG
- D- Antigène HBe
- E- Ac anti HBs

31. Devant un patient présentant une hépatite aigue virale, vous évoquer un tableau grave si vous constatez :

- A. Des arthralgies intenses.
- B. Une augmentation du volume du foie.
- C. Un prurit intense.
- D. Des gingivorragies
- E. Des troubles neuropsychiques.

32. Pour confirmer le diagnostic d'une hépatite aigue B vous cherchez la positivité de :

- A. Ac anti-HBs
- B. Antigène HBs
- C. Ac anti-HBc de type IgG
- D. Ac anti-HBc de type IgM
- E. Antigène HBe

33. La vaccination contre l'hépatite virale est possible pour le(s) virus suivant(s):

- A. Virus A
- B. Virus B
- C. Virus C
- D. Virus D
- E. Virus E

34. Devant un patient présentant une hépatite aigue, l'origine virale est évoquée devant le(s) éléments(s) suivant(s) :

- A. Les antécédents de scarifications.
- B. L'installation aigue des symptômes.
- C. La présence d'arthralgies
- D. L'asthénie intense.

E. Le syndrome pseud-grippal

35. Un dépistage de l'hépatite B est légalement obligatoire dans les situations suivantes :

- A. Bilan prénuptial
- B. Bilan d'embauche.
- C. Donneur de sang.
- D. Avant de partir à l'étranger.
- E. Femme enceinte

36. Le traitement de l'hépatite virale C en Tunisie est basée actuellement sur :

- A. Entécavir + ribavirine
- B. Interféron pégylée + ribavirine
- C. Sofosbuvir + Velpatasvir
- D. Lamivudine + Ribavirine
- E. Interféron pégylée seule

37. Au cours d'une hépatite aiguë, les éléments cliniques qui sont en faveur d'une hépatite grave sont :

- A. une hépatomégalie importante
- B. des ecchymoses cutanées
- C. un ictère très foncé
- D. un astérix
- E. l'apparition de troubles de la conscience.

B- Epreuve cas cliniques (30 questions)

a- Cas clinique n°1 (19 QCM)

Patiente Mouna S. de 29 ans, originaire de Msaken, se plaint depuis 2 semaines d'asthénie intense avec ictère d'allure cholestatique.

- * Signes fonctionnels associés : somnolence, anorexie, vomissements post-prandiaux et polyarthralgie.
- * Non vaccinée contre l'hépatite virale B.
- * A l'examen : ictère conjonctival, traces d'injections intraveineuses aux deux bras en rapport avec une toxicomanie affirmée par la patiente.

Vous évoquez le diagnostic d'hépatite virale aiguë.

1- L'examen biologique le plus utile en faveur du diagnostic d'hépatite aiguë est :

- A- Bilirubinémie.
- B- Taux de prothrombine.
- C- Electrophorèse des protéines sériques.
- D-Transaminases sériques.
- E- Numération de la formule sanguine.

2- Le signe clinique vous fait craindre une hépatite grave chez cette patiente est :

- A- Asthénie intense.
- B- Anorexie
- C- Polyarthralgies.
- D- Somnolence.
- E- Vomissements.

3- Vous évoquer une hépatite grave chez cette patiente si vous constatez à l'examen physique les signes suivants :

- A- Astérixis
- B- Hépatomégalie > 16 cm
- C- Splénomégalie
- D- Lésions ecchymotiques cutanées
- E- Urticaire.

4- Quel est l'examen biologique qui vous permet d'évaluer la gravité de l'hépatite aiguë chez cette patiente ?

- A- Taux des transaminases sériques.
- B- Taux de bilirubinémie
- C- Taux des plaquettes.
- D-Taux de prothrombine.
- E- Taux d'hémoglobine.

5- En plus du paramètre précédent, les autres paramètres biologiques qui vous permettent d'évaluer la gravité de l'hépatite chez cette patiente sont:

- A- Taux des plaquettes.
- B- Taux de glycémie
- C- Taux de cholestérolémie.
- D- Taux de créatininémie.
- E- Taux de CRP.

6- Cette patiente, toxicomane, fait partie d'un groupe à haut risque d'infection pour le(s) virus suivant(s) :

- A- Virus de l'hépatite A.
- B- Virus de l'hépatite B.
- C- Virus de l'immuno-déficience humaine (VIH).
- D- Virus de l'hépatite E
- E- Virus de l'hépatite C.

7- Le diagnostic d'hépatite aiguë non grave est porté chez cette femme. La recherche d'antigène HBs est positive. Quelle recherche doit être positive pour rapporter au virus B cette hépatite aiguë ?

- A- Recherche de l'antigène Hbe.
- B- Recherche d'anticorps anti HBs.
- C- Recherche de l'antigène HBc.
- D- Recherche d'anticorps anti Hbe.
- E- Recherche d'anticorps anti HBc de type IgM.

8- Le diagnostic d'hépatite aiguë B non grave, AgHBe négatif, a été retenu chez cette patiente, vous proposez comme traitement :

- A- Extraits hépatiques en intramusculaire.
- B- Prednisone 1 mg/kg/j per os.
- C- Entécavir per os 1cp/j au long cours.
- D- Interféron en sous-cutané pendant 1 an.
- E- Traitement symptomatique.

9- Afin d'éviter la contamination de l'entourage vous conseillez la patiente :

- A- De ne pas partager son coupe ongle avec les autres.
- B- De ne pas manger dans la même assiette avec les autres.
- C- De ne pas utiliser les habits des autres.
- D- De mettre une bavette couvrant la bouche et le nez jusqu'à disparition de l'ictère.
- E- D'éviter définitivement les rapports sexuels non protégés avec son mari.

10- A plus ou moins long terme l'hépatite aiguë B, chez la patiente, peut se compliquer de :

- A- Insuffisance rénale.
- B- Cirrhose.
- C- Etat de choc septique.
- D- Hépatocarcinome.
- E- Hépatite chronique active.

11- Deux semaines plus tard, une infirmière au dispensaire local a prélevé un bilan de contrôle chez cette patiente, et par faute d'inattention lors du prélèvement elle s'est piquée par l'aiguille souillée de sang. Vous devez immédiatement indiquer chez cette infirmière :

- A- L'injection de gamma-globulines standards.
- B- L'injection de gamma-globulines anti HBs.
- C- Le traitement par entécavir.
- D- Le traitement par interféron.
- E- De faire juste un rappel de vaccination anti-B.

12- Dans le cadre de l'enquête familiale pour le virus B, le frère de la patiente, âgé de 40 ans, vient d'avoir une sérologie virale B montrant les résultats suivants: AgHbs (-) , Ac anti-Hbs (+), IgM anti-Hbc (-), IgG anti-Hbc (+), Ag Hbe(-), Ac anti-Hbe (-).

Ce profil sérologique du frère est en faveur de :

- A- Hépatite chronique B active.
- B- Patient vacciné contre le virus B.
- C- Portage inactif du virus B.
- D- Hépatite B ancienne « guérie » (immunisée).
- E- Hépatite aiguë B.

13- Le mari de cette patiente, ayant une sérologie B négative, a été vacciné contre l'hépatite B lorsque sa femme a développé son hépatite aiguë. A l'examen sérologique de ce mari effectué 4 mois après la vaccination, on s'attend à trouver :

- A- Les anticorps anti delta.
- B- Les anticorps anti HBe.
- C- Les anticorps anti HBc type IgG.
- D- Les anticorps anti HBs.
- E- Les anticorps anti HBc type IgM.

14- Les injections du vaccin anti-B pratiqué chez le mari seront faites selon le protocole recommandé suivant :

- A- M0, M3, M6
- B- M0, M6, M12
- C- M0, M1, M6
- D- M0, M12, M24
- E- M0, M1, M3.

15- Le(s) paramètre(s) biologique(s) que vous demandez chez cette patiente afin de rechercher une hépatite chronique B active est (sont):

- A- Taux des transaminases.
- B- Taux de l'antigène HBs.
- C- Taux des GGT.
- D- Taux de l'ADN viral B.
- E- Taux de la bilirubinémie.

16- Le bilan à 6 mois fait chez cette patiente a montré : ALAT = 120, ASAT= 100, PAL = 100, GGT = 45, BT= 15 ; ADN viral B = 10 000 UI/mL.

Vous proposez pour cette patiente :

- A- Un contrôle du même bilan à 6 mois.
- B- Un traitement par interféron pégylée.
- C- Un traitement par Entécavir.
- D- Un fibroscan hépatique.
- E- Un fibrotest.

17- Un fibroscan hépatique a été pratiqué chez cette patiente et a montré une fibrose hépatique classée F3.

Vous proposez en première intention pour cette patiente le traitement suivant :

- A- Un traitement par Sofosbuvir + Ledipasvir.
- B- Un traitement par interféron pégylée.
- C- Un traitement par Entécavir.
- D- Un traitement par Ténofovir
- E- Un traitement par Corticoïdes.

18- Au 12^{ème} mois du traitement antiviral, l'ADN viral B était indétectable.

La patiente est tombée enceinte et a accouché d'une fille en bonne état de santé.

Votre attitude immédiate chez la fille pour la prévention de l'hépatite B sera :

- A- Traitement antiviral B préventif jusqu'à l'âge de 6 mois.
- B- Vaccination anti-B seule.
- C- Sérothérapie anti-HBs seule
- D- Association sérothérapie anti-HBs + vaccination anti-B
- E- Simple surveillance.

19- Selon le dernier calendrier vaccinal tunisien, la fille de la patiente devrait être vaccinée contre l'hépatite B selon le schéma suivant :

- A- M0, M1, M6
- B- M0, M2, M6
- C- M0, M1, M2, M6
- D- M0, M2, M3, M6
- E- M0, M2, M3, M6, M12

b- Cas clinique n°2 (4 QCM)

Un homme de 40 ans, originaire de Béja, consulte pour une asthénie d'aggravation progressive depuis 6 mois.

* A l'interrogatoire :

- Arthrose des genoux sous Paracétamol à la demande.
- Diabète type 2 depuis 10 ans sous Glucophage.
- Consommation d'alcool 50 g/j depuis 2 ans.
- Marié et père de 2 enfants.

* A l'examen physique : Scarifications du visage, IMC = 36 kg/m².

* Au bilan biologique :

ALAT = 160 UI, ASAT = 120, BT = 15 µmol/L, BD = 10 µmol/L, PAL = 100 UI.

NFS : Hb = 13,5 g/dl, GB = 5800, Plq = 290 000

Créatininémie = 70 µmol/L, glycémie = 5,1 mmol/L

1- Le dosage essentiel qui manque dans le bilan biologique de ce patient est :

- A- GGT
- B- Cholestérolémie
- C- TP

D- Albuminémie

E- Ionogramme sanguin.

2- La première étiologie à évoquer chez ce patient est :

A- Hépatite médicamenteuse

B- Hépatite auto-immune

C- Hépatite virale

D- Hépatite alcoolique

E- Stéato-hépatite.

Parmi le bilan demandé chez ce patient, la sérologie C a montré des Ac anti-VHC positifs avec un taux d'ARN viral C = 900 UI/ml. Un traitement antiviral a été indiqué.

3- Le bilan pré thérapeutique à pratiquer chez ce patient comporte :

A- Sérologie VIH

B- Génotype viral C

C- Echographie abdominale

D- Fibroscan hépatique

E- Alpha-fetoprotéine

4- Le traitement que vous proposez chez ce patient est :

A- Sofosbuvir en monothérapie

B- Ledipasvir en monothérapie

C- Association Sofosbuvir + Velpatasvir

D- Association Sofosbuvir + Ribavirine

E- Interféron pégylé en monothérapie.

c- Cas clinique n°3 (7 QCM)

Vous venez de recevoir en consultation un homme de 55 ans présentant une asthénie progressive depuis 2 semaines associée à des arthralgies diffuses. Il est marié et il occupe la fonction d'un infirmier dans l'hôpital régional de Gafsa depuis 15 ans. Il se plaint depuis 7 jours d'une sensation de pesanteur de l'hypochondre droit associé à des urines foncées.

A l'examen physique : $T^{\circ} = 37^{\circ}\text{C}$, ictère conjonctival, un foie de taille normale mais sensible à la palpation. Tatouages du bras gauche. Le reste de l'examen est normal.

Les résultats d'un bilan biologique demandé par le médecin qu'il avait consulté quelques jours plus tôt, sont : Bilirubine totale = $55 \mu\text{mol/L}$, Bilirubine conjuguée = $43 \mu\text{mol/L}$, ALAT = 1200 UI/L , ASAT = 1000 UI/L , TP = 80%. Une hépatite aiguë virale est évoquée.

1- Les arguments en faveur du caractère aigue de l'hépatite chez ce patient sont :

- A- L'âge jeune
- B- L'absence d'hépatomégalie à l'examen
- C- L'évolution des symptômes depuis 2 semaines.
- D- Le taux d'ALAT à 1200 UI
- E- L'ictère.

2- Les arguments en faveur de l'origine virale de l'hépatite chez ce patient sont :

- A- L'âge jeune
- B- La profession
- C- Le tatouage
- D- L'asthénie
- E- Le taux d'ALAT à 1200 UI

3- Dans le cadre du bilan étiologique de cette hépatite aigue, vous recherchez en premier les virus suivants :

- A- Virus A
- B- Virus B
- C- Virus C
- D- Virus D
- E- Virus E

4- Le bilan virologique demandé a conclu à une hépatite B aigue. Le paramètre sérologique qui vous a permis de retenir ce diagnostic est :

- A- Antigène HBs positif
- B- Anticorps anti-HBe positifs
- C- Antigène HBe positif
- D- Anticorps anti-HBc IgG positifs
- E- Anticorps anti-HBc IgM positifs

5- Dans le cadre du suivi de ce patient, le paramètre qui vous permet de dépister le passage à la chronicité du virus B est :

- A- Antigène HBs
- B- Anticorps anti-HBe
- C- Antigène HBe
- D- Anticorps anti-HBc IgG
- E- Anticorps anti-HBc IgM

Le patient n'a pas effectué le suivi recommandé et consulte inquiet, un an plus tard, avec le résultat du bilan biologique récent fait à la clinique : ASAT = 60 UI/L, ALAT = 70 UI/L, Ag HBs(+) ,Ac anti HBs(-), Ag Hbe(+) , Ac anti Hbe (-), IgM anti-HBc (-), ADN viral B = 190 000 UI/mL. Une Ponction biopsique du foie a été réalisée chez ce patient montrant un score de Métavir égal à A1 F3.

6- Vous proposez pour ce patient le traitement suivant :

- A- Entécavir
- B- Ganciclovir
- C- Lamivudine
- D- Sofosbuvir + Velpatasvir
- E- Ribavirine

7- Dans le cadre de l'enquête familiale, vous allez proposer pour la femme de ce patient le(s) dosage(s) suivant(s) :

- A- Antigène HBs
- B- Anticorps anti-HBe
- C- Antigène HBe
- D- Anticorps anti-HBc IgG
- E- Anticorps anti-HBc IgM

Fin de l'évaluation

Bonne chance